

QCM - ORL - Section Fr

1. *Le principal symptôme clinique dans l'otosclérose est:
 - A. Le vertige
 - B. l'acouphène tinnitus
 - C. Hypoacousie de perception
 - D. sensation de plénitudes auriculaire
 - E. hypoacousie de transmissionREP: E
2. *Le traitement de choix de cholestéatome est :
 - A. Les antibiotiques
 - B. la chimiothérapie
 - C. radiothérapie
 - D. chirurgical
 - E. physiothérapieREP: D
3. *Les propositions suivantes en rapport avec la tuberculose laryngée sont correctes à l'exception de :
 - A. l'âge de prédilection survient après 60 ans
 - B. est secondaire à la tuberculose pulmonaire
 - C. ensemencement de la B. Koch se fait par expectorations trachéobronchique ou par voie hématologique
 - D. le traitement est spécifique est effectué dans un réseau de spécialité
 - E. l'âge de prédilection se situe entre 20-40 ansREP: A
4. * Collection de sang entre le périchondre septal et cartilage septal est appelé :
 - A. Un hématome des sinus
 - B. luxation de la pyramide nasale
 - C. fracture de la pyramide nasale
 - D. l'hémangiome
 - E. hématome septalREP: E
5. * Les fosses nasales ont 4 murs :
 - A. Inférieur (septum), supérieur (voûte), moyen (plancher), latérales (cornets et méats)
 - B. Inférieur (plancher), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méats)
 - C. Inférieur (voûte), moyen (septum), supérieur (cornets et méats), latérales (plancher)
 - D. Inférieur (plancher), moyen (cornets et méats), latérales (voûte), supérieur (septum)
 - E. Inférieur (cornets et méats), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méat)REP: B
6. *Faciès adénoïdien est caractérisé par les propositions suivantes sauf :
 - A. La lèvre supérieure rétractées
 - B. le visage congestionné avec un regard perdu
 - C. lèvre inférieures inerte
 - D. bouche ouverte
 - E. petit nezREP: B
7. * Etage sus-glottique ne contient pas de :
 - A. bandes ventriculaires
 - B. face laryngée de l'épiglotte
 - C. aryénoïdes
 - D. replis aryéno-épiglottique
 - E. cordes vocalesREP: E

8. *Le diagnostic de certitude des tumeurs malignes du rhinopharynx sont mise en évidence par :
- A. Biopsie du nasopharynx
 - B. ECG
 - C. l'anamnèse
 - D. radiographie pulmonaire
 - E. l'échographie cervicale
- REP: A
9. *Adénoïdes aiguë est une inflammation aiguë a :
- A. l'amygdale linguale
 - B. les amygdales palatines
 - C. amygdales Gerlach
 - D. amygdale oropharyngée
 - E. amygdale Luschka
- REP: E
10. *Le larynx :
- A. Est un organe musculaire fibro-cartilagineux
 - B. est divisé en 3 étages : supra glottique, glottique et sous-glottique
 - C. en continuation avec la trachée
 - D. est formée d'un cartilage élastique: épiglotte
 - E. toutes les réponses sont correctes
- REP: E
11. * Lequel des laryngite chronique suivantes est spécifique :
- A. Hypertrophique blanche
 - B. catarrhale
 - C. atrophique
 - D. syphilis
 - E. hypertrophique rouge
- REP: D
12. * Dans la surdité brusque le tympan est :
- A. Perforé avec sécrétions purulentes
 - B. bombé
 - C. congestionné
 - D. avec vésicules
 - E. normal
- REP: E
13. * Les propositions suivantes sont les causes locales de l'épistaxis à l'exception de :
- A. Un traumatisme de la pyramide nasale
 - B. Rhinophyma
 - C. polype saignant de la cloison nasale
 - D. tumeurs malignes naso-sinusiennes
 - E. la rhinite aiguë et chronique
- REP: B
14. * Le sinus maxillaire :
- A. N'est pas le plus grand des sinus
 - B. draine au niveau du méat supérieur
 - C. ponction exploratrice ou thérapeutique dans le méat moyen
 - D. draine au niveau du méat moyen
 - E. draine au niveau du méat inférieur
- REP: D
15. * L'une des propositions suivantes ne fait pas partie des causes de la surdité acquise :
- A. Traitement avec de la Kanamycine
 - B. la méningite
 - C. l'anémie
 - D. le traitement par la quinine
 - E. la parotidite épidémique
- REP: C

16. Rhinite aiguë non spécifique :

- A. La rhinite pseudomembraneuse (streptocoque, pneumocoque)
- B. la rhinite streptococcique
- C. la rhinite septique chez l'adulte
- D. rhinite infectieuse à staphylococcus aureus
- E. la rhinite aiguë banale: coryza ou nez qui coule

REP: ABDE

17. Angine érythémato pultacée:

- A. Streptocoque bêta-hémolytique est l'agent étiologique
- B. on administre de la pénicilline, l'érythromycine ou l'amoxicilline
- C. pas de modification de l'ASLO
- D. l'agent étiologique sont bacilles fusiformes
- E. on ne trouve pas d'adénite sous-maxillaire

REP : AB

18. Les tumeurs malignes du cavum:

- A. La phase d'état présente cinq formes: rhinologique, otologique, neurologiques, ophtalmologique, ganglionnaire
- B. phase otologique comprend: acouphènes, autophonie, surdité de perception, otite chronique catarrhale rebelle au traitement, parfois otite moyenne aiguë
- C. formes anatomo-pathologiques: épidermoïdes 85-95% (indifférenciées, moins différenciées, différenciées)
- D. l'hypothèse d'origine virale sont fréquemment rencontré est en augmentation (Epstein-Barr)
- E. phase ganglionnaire (adénopathie cervicale haute ou dans l'espace entre la pointe de la mastoïde et la branche verticale de la mandibule). Apparaît comme un bloc ganglionnaire avec une consistance molle, non fixé, douloureux à la palpation

REP : ACD

19. La cavité buccale est délimitée :

- A. supérieur du plancher buccal
- B. antérieur des lèvres
- C. inférieur du palais osseux avec l'os palatin
- D. cloison nasal vers l'antérieur
- E. postérieur du voile du palais

REP : BE

20. Quelles angines aiguës appartiennent à certaines affection hématologiques :

- A. angine érythémato pultacée
- B. l'angine et la fièvre aphteuse
- C. l'angine agranulocytaire
- D. l'angine leucémique
- E. angine de la zona zoster

REP : CD

21. Deux de ces variantes sont des tumeurs malignes de l'oro/buccopharynx :

- A. angiofibrome du nasopharynx
- B. lipome pharyngée
- C. le cancer de l'amygdale palatine
- D. cancer de la luette
- E. une tumeur du rinopharynx

REP : CD

22. Cancer des amygdales palatines :
- A. Une immunothérapie est le traitement de base
 - B. le diagnostic de certitude est mise en évidence par ex HP
 - C. l'examen de l'oropharynx est un examen qui le met en évidence
 - D. représente cancer de l'hypopharynx
 - E. est la tumeur la plus fréquente du pharynx (unilatérale)
- REP: BCE
23. Les parois supérieures des fosses nasales se compose du :
- A. temporal
 - B. frontal
 - C. sphénoïdal
 - D. l'os nasal
 - E. ethmoïdal
- REP : BCDE
24. Étages du larynx sont :
- A. antérieur
 - B. postérieur
 - C. glottique
 - D. sus-glottique
 - E. sous-glottique
- REP : CDE
25. Les symptômes du cancer des amygdales comprennent :
- A. Epistaxis répétée
 - B. odynophagie
 - C. l'obstruction nasale progressive
 - D. la dysphagie
 - E. la perte de poids
- REP : BDE
26. Trois de ces variantes sont des tumeurs malignes de l'oro/buccopharynx :
- A. Le cancer du voile du palais
 - B. cancer de l'amygdale palatine
 - C. le cancer des sinus piriforme
 - D. le cancer de la base de la langue
 - E. le cancer du cavum
- REP: ABD
27. Les tumeurs bénignes du larynx sont les suivantes :
- A. Nodules vocaux
 - B. la diphtérie laryngée
 - C. le carcinome spinocellulaire
 - D. hémangiome
 - E. polypes laryngés
- REP: ADE
28. Tuberculose du pharynx :
- A. apparition des lésions profondes destructives, non douloureuse
 - B. 4 étapes sont décrites: cru, ramolli, le stade de l'ulcération, cicatrisation
 - C. tuberculose miliaire aiguë, apparaît chez les jeunes ayant une tuberculose pulmonaire cavitaires, état fébrile 39-40°C, asthénie marquée, transpiration, perte de poids, odynophagie, dysphagie marquée, sialorrhée, perte d'appétit
 - D. les formes cliniques: tuberculose miliaire aiguë (Isambert), tuberculose ulcéreuse, sous une forme latente, le lupus du pharynx, abcès froid rétropharyngée
 - E. la tuberculose pulmonaire secondaire (=> sens de secondaire à la TBC pulmonaire)
- REP: CDE

29. Patients avec abcès septal présente :

- A. Fièvre 36-37 degrés celsius
 - B. céphalées
 - C. épistaxis
 - D. douleur locale
 - E. la dysphagie
- REP : ABD

30. Malformation du larynx sont représentée par :

- A. trachéotomie
 - B. laryngocèle
 - C. membrane palmata
 - D. piocel
 - E. laryngomalacie
- REP: BCE

31. Inflammation chronique spécifique, syphilis pharyngée :

- A. Syphilis primaire: forme d'angine (fièvre, odynophagie, des amygdales hypertrophiée bilatérale, rouge, adénopathie satellite)
 - B. syphilis congénitale, acquis
 - C. etiologie: treponema pallidum
 - D. la syphilis primaire: RBW positif après 4-5 semaines après le début de la phase primaire, est la période de contagiosité maximale
 - E. phases cliniques: primaire, secondaire, tertiaire
- REP: BCE

32. Cordes vocales :

- A. sont situées à l'étage sous-glottique
 - B. ont un rôle dans la phonation
 - C. sont situés à l'étage sus-glottique
 - D. sont situés à l'étage glottique
 - E. leur face supérieur constitue le plancher du ventricule de morgagni
- REP: BD(E)

33. Lequel des éléments suivants ne représentent PAS la rhinite aiguë spécifique :

- A. La rhinite rougeole
 - B. la rhinite aiguë banale
 - C. la rhinite diphtérique
 - D. la rhinite streptococcique
 - E. la rhinite scarlatineuse
- REP: BD

34. Dans la syphilis primaire le patient peut présenter :

- A. une otorrhée fétide
 - B. des acouphènes
 - C. hypoacousie de perception
 - D. troubles d'équilibre
 - E. hypoacousie de transmission
- REP : BCD

35. Fibrome du rinopharynx:

- A. dosage de 17 cétostéroïdes montre un surplus, la tumeur se développe jusqu'à 20 ans
 - B. épistaxis répété chez le patient de sexe masculin en période de puberté
 - C. l'étiologie endocrinienne est souvent incriminé
 - D. obstruction nasale rapide
 - E. apparaît principalement chez les hommes est considérée comme la tumeur de la puberté masculine
- REP: ABCE

36. La maladie de Ménière est caractérisée par :
- A. hypoacousie de perception immédiate suivie d'une récupération lente de l'audition
 - B. les acouphènes
 - C. otorrhée fétide
 - D. début brusque
 - E. vertiges de type rotatoires
- REP : ABDE
37. L'hémostase de l'épistaxis est réalisée par :
- A. le tamponnement antérieur
 - B. cautérisation de la tache vasculaire avec une perle de nitrate d'argent
 - C. appliquer des compresses chaudes sur les fosses nasales
 - D. le tamponnement postérieur
 - E. la compression digitale de l'aile du nez
- REP : ABDE
38. Le larynx est composé de :
- A. Cartilage thyroïde
 - B. cartilage cricoïde
 - C. cartilage arythénoïde
 - D. épiglotte
 - E. amygdale palatine
- REP: ABCD
39. les formes anatomo-clinique de l'épistaxis sont:
- A. Antérieur
 - B. hypertensive
 - C. diabétique
 - D. postérieur
 - E. unilatéral
- REP: AD
40. Deux de ces variantes sont des tumeurs malignes de l'oro/buccopharynx :
- A. Cancer des amygdales palatines
 - B. cancer de la luette
 - C. angiofibrome nasopharyngé
 - D. tumeur rhinopharyngée
 - E. lipome pharyngien
- REP: AB
41. Le diagnostic différentiel de l'imperforation des choanes se fait avec:
- A. corps étranger nasal
 - B. Voile palatine fracturé
 - C. adénoïdite aiguë
 - D. polypose nasale
 - E. tumeurs maligne naso sinusale
- REP: ACDE
42. Les amygdales rhinopharyngées:
- A. Sont situés dans l'hypopharynx
 - B. est appelé amygdale de Luschka
 - C. est situé sur la paroi supérieur et postérieur du rhinopharynx
 - D. est constitué de tissu lymphoïde
 - E. bloque le sinus piriforme
- REP: BCD

43. Le diagnostic des tumeurs glomiques repose sur les éléments suivants :
- A. Surdit  de transmission pouvant devenir de perception
 - B. Acouph ne n' tant jamais synchrone avec le pouls
 - C. vertiges et otalgies mod r s et intermittents
 - D. les polypes apparaissent en CAE charnu, rouge tre, saignant sur place et spontan ment
 - E. la paralysie du nerf facial survient fr quemment
- REP: ACDE
44. Lequel des  nonc s suivants permet le diagnostic positif de la tuberculose laryng e :
- A. Etat f brile, subf brile
 - B. IDR la PPD
 - C. bucco pharyngoscopie
 - D. rhinoscopie ant rieure
 - E. examen bact riologique des crachats
- REP: ABE
45. Amygdalite chronique
- A. inflammation chronique des amygdales p les s'accompagne d'une hyperplasie de tous les  l ments de la structure et de la pr sence de cas um   l'int rieur des cryptes
 - B. Facteurs favorisants : amygdalite aigu  r p t e dans l'enfance, ad no dite aigu  r p t e, ad no dite chronique, baisse de l'immunit  de l'organisme
 - C. Formes cliniques: atrophiques, hypertrophiques (chez les enfants, l'hypertrophie des tissus lympho ides pr domine - consistance molle chez les adultes, l'hypertrophie des tissus articulaires pr domine)
 - D. Une bioth rapie orale ou syst mique est recommand e
 - E. Oropharyngoscopie : s cr tions purulentes qui s' coulent sur la paroi post rieure de l'oropharynx, amygdales hypertrophiques ou atrophiques avec cas um dans les cryptes
- REP: ABCE
46. Le traitement des  pistaxis comprends :
- A. traitement de la cause qui a g n r  le saignement
 - B. alimentation orale
 - C. Arr t de l'h morrhagie
 - D. traitement symptomatique
 - E. seulement un r  quilibrage de l' tat g n ral
- REP: ACD
47. Les causes locales qui peuvent d terminer les h morrhagies nasales :
- A. perforation septale
 - B. corps  trangers nasal
 - C. pharyngite chronique
 - D. fibrome nasopharyng 
 - E. sinusite aigu 
- REP: ABD
48. Parmi les causes suivantes, lesquelles sont des causes g n rales d' pistaxis :
- A. HTA
 - B. Rhinite aigu  et chronique
 - C. troubles h matologique
 - D. maladie infectieuse aigu 
 - E. grossesse
- REP: ACD

49. les tumeurs malignes de l'hypopharynx (cancer du sinus piriforme)

- A. la localisation la plus fréquente des cancers de l'hypopharynx
 - B. diagnostic: adénopathie latéro cervicale tardive
 - C. sensation de corps étranger, odynophagie, dysphagie, otalgie réflexe, hypoacousie de transmission
 - D. hypopharyngoscopie: laryngoscopie indirecte, fibroscopie, oesophagoscopie, radiographie avec substance de contraste et CT
 - E. diagnostic de certitude, biopsie, traitement: chirurgical, radiothérapie, chimiothérapie
- REP: ADE

50. L'innervation du larynx est fourni par :

- A. Nerf accessoire
 - B. les nerfs récurrents
 - C. pneumogastrique
 - D. les nerfs XII
 - E. nerfs laryngés supérieurs
- REP : BCE

QCM ORL - 2020

1. *Faciès adénoïdien est caractérisé par les propositions suivantes, sauf :
 - A. lèvre inférieure inerte
 - B. la lèvre supérieure rétractée
 - C. le visage congestionné avec un regard perdu
 - D. petit nez
 - E. bouche ouverteREP: C
2. *Les fosses nasales ont 4 murs :
 - A. Inférieur (septum), supérieur (voûte), moyen (plancher), latérales (cornets et méats)
 - B. Inférieur (plancher), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méats)
 - C. Inférieur (voûte), moyen (septum), supérieur (cornets et méats), latérales (plancher)
 - D. Inférieur (plancher), moyen (cornets et méats), latérales (voûte), supérieur (septum)
 - E. Inférieur (cornets et méats), supérieur (voûte), moyen (septum), latérales (cornets et méat)REP: B
3. les tumeurs malignes de l'hypopharynx (cancer du sinus piriforme)
 - A. la localisation la plus fréquente des cancers de l'hypopharynx
 - B. diagnostic: adénopathie latéro cervicale tardive
 - C. sensation de corps étranger, odynophagie, dysphagie, otalgie réflexe, hypoacousie de transmission
 - D. hypopharyngoscopie: laryngoscopie indirecte, fibroscopie, oesophagoscopie, radiographie avec substance de contraste et scanner
 - E. diagnostic de certitude, biopsie, traitement: chirurgical, radiothérapie, chimiothérapieREP: ADE
4. Une laryngoscopie indirecte sera appliquée à un patient qui présente dysphonie, qui dure des 2 mois, visualisant des éléments anatomo-cliniques suivants:
 - A. Espace glottique qui comprend les fosses corpiques de vocale, la commissure antérieure et postérieure
 - B. L'espace sous-glottique qui comprend l'espace inférieure de la glotte jusqu'au 1er anneau trachéal
 - C. Le septum glottique qui comprend les vrais cordes vocales la commissure antérieure et postérieure
 - D. L'espace supra-glottique comprenant les fausses corpiques de vocale, l'épiglotte, les enveloppes ary-épiglottique, les cartilage aryénoïde
 - E. l'espace supra-glottique comprenant les fausses et les vrais corpiques de vocale, l'épiglotte, les enveloppes ary-épiglottique, les cartilage aryénoïdeREP: BCD
5. Le test de Schwabach
 - A. Analyse objectivement la transmission du son
 - B. Dure environ 20 secondes
 - C. Analyse subjectivement la transmission osseuse du son
 - D. Est calculé en effectuant le rapport entre la transmission osseuse et celle aérienne
 - E. Une perte auditive de transmission dans l'oreille au cours de laquelle le test de Schwabach est effectué va générer une augmentation de la durée plus de 20 secondesREP: BCE

6. Un patient qui montre une dysphonie depuis 2 mois se présente à la clinique ORL. Une laryngoscopie indirecte sera réalisée, ce qui implique les éléments suivants:
- A. Le patient est invité à faire sortir la langue, le médecin enroulé la langue du patient entre deux doigts avec un tampon de gaze et à l'aide d'un miroir laryngée préchauffer, appuie vers la luette avec la surface brillante du miroir diriger vers le bas, vers le larynx
 - ☒ B. Il faut appuyer avec une spatule sur la langue et insérer le miroir avec la surface brillante vers le bas pour visualiser le larynx
 - C. Il faut appuyer avec une spatule sur la langue et insérer le miroir avec la surface brillante vers le haut
 - D. À l'aide du miroir la ranger les trois stades du larynx se sont visualiser : supra-glottique, glottique, sous-glottique
 - E. Il faut appuyer avec une spatule sur la langue et visualiser le larynx
- REP: AD
7. Les amygdales rhinopharyngée:
- A. Sont situé dans l'hypopharynx
 - B. est appelé amygdale de Luschka
 - C. est situé sur la paroi supérieur et postérieur du rhinopharynx
 - D. est constitué de tissu lymphoïde
 - E. bloque le sinus piriforme
- REP: BCD
8. Lequel des énoncés suivants permet le diagnostic positif de la tuberculose laryngée :
- A. rhinoscopie antérieure
 - B. IDR la PPD
 - C. Examen de l'oropharynx
 - D. le traitement symptomatique
 - E. examen bactériologique des crachats
- REP: BDE
9. Le diagnostic des tumeurs glomiques est mis en évidence selon les éléments suivants:
- A. L'otalgie et le vertige, intermittent
 - B. Une surdité de transmission peut devenir de perception
 - C. Paralyse du nerf facial qui se produit fréquemment
 - D. Les acouphènes qui ne sont jamais synchrone avec le pouls
 - E. Les polypes apparus dans CAE charnu, rouge saignent à la palpation et spontanément
- REP: ABCE
10. Test de Rinne:
- A. Évalue également la conduction osseuse et aérienne
 - B. Analyse objectivement la transmission du son
 - C. Et calculer en effectuant le rapport entre l'air et la transmission osseuse
 - D. Un rapport normal entre l'air et la conduction osseuse est de 3/1
 - E. Analyse subjectivement la transmission du son
- REP: ACE
11. Amygdalite chronique:
- A. Antibiotiques par voie orale ou systémique est recommandé
 - B. L'examen de l'oropharynx de points sécrétion purulente qui coule des paroi postérieure du bucco pharynx, amygdales hypertrophique ou atrophique avec du caseum cryptique
 - C. Formes cliniques : atrophique, hypertrophique (chez les enfants prédomine l'hypertrophie du tissu lymphoïde consistance molle, chez l'adulte prédomine hypertrophie du tissu conjonctif)
 - D. L'inflammation chronique des amygdales, accompagné par une hyperplasie de l'ensemble des éléments de la structure et de la présence du caseum à l'intérieur des cryptes
 - E. Les facteurs prédisposants: amygdalite aiguë récurrente à l'enfance, adénoïdite aiguë et répétée, adénoïde chronique faiblesses du système immunitaire
- REP: BCDE

12. Lequel des éléments suivants ne représentent PAS la rhinite aiguë spécifique:
- A. La rhinite streptococcique
 - B. La rhinite rougeole
 - C. La rhinite diphtérique
 - D. La rhinite scarlatine
 - E. La rhinite aiguë banale
- REP: AE
13. Un patient adulte se présente pour consultation ORL avec une dysphonie (enrouement). Laquelle des procédures suivantes sera appliqué pour établir le diagnostic :
- A. Bucco pharyngoscopie
 - B. Fibroscopie nasale laryngée
 - C. laryngoscopie indirect
 - D. laryngoscopie directe
 - E. Rhinoscopie postérieure
- REP: ABD
14. Les symptômes du cancer des amygdales comprennent:
- A. Odynophagie
 - B. La perte de poids
 - C. Épistaxies répéter
 - D. L'obstruction nasale progressive
 - E. La dysphagie
- REP: ABE
15. Causes locales qui peuvent provoquer des hémorragies nasales sont:
- A. Un corps étranger nasal
 - B. Fibrome nasopharynx
 - C. La perforation septale
 - D. Pharyngite chronique
 - E. La sinusite aiguë
- REP: ABC
16. Les parois supérieures des fosses nasales se compose du:
- A. Nasal l'os nasal
 - B. ethmoïdal
 - C. Frontal
 - D. sphénoïdal
 - E. Temporal
- REP: ABD
17. Cancer des amygdales palatines :
- A. Une immunothérapie est le traitement de base
 - B. le diagnostic de certitude est mise en évidence par ex HP
 - C. l'examen de l'oropharynx est un examen qui le met en évidence
 - D. représente cancer de l'hypopharynx
 - E. est la tumeur la plus fréquente du pharynx (unilatérale)
- REP: BCE
18. Les tumeurs malignes du cavum:
- A. La phase d'état présente cinq formes: rhinologique, otologique, neurologiques, ophtalmologique, ganglionnaire
 - B. phase otologique comprend: acouphènes, autophonie, surdité de perception, otite chronique catarrhale rebelle au traitement, parfois otite moyenne aiguë
 - C. formes anatomo-pathologiques: épidermoïdes 85-95% (indifférenciées, moins différenciées, différenciées)
 - D. l'hypothèse d'origine virale sont fréquemment rencontré est en augmentation (Epstein-Barr)
 - E. phase ganglionnaire (adénopathie cervicale haute ou dans l'espace entre la pointe de la mastoïde et la branche verticale de la mandibule). Apparaît comme un bloc ganglionnaire avec une consistance molle, non fixé, douloureux à la palpation
- REP : ACD

